

Group Project 6

Ce document reprend, semaine après semaine, le travail réalisé dans le cadre du cours.

Semaine 3

Le contact avec la personne de référence a pris un peu de temps, mais après l'envoi d'un mail par le professeur, il a finalement été établi et nous avons pu planifier un rendez-vous sur Teams.

Semaine 4

Nous nous sommes appelés afin de préparer la réunion du mercredi 4 mars. Lors de cet échange, nous avons élaboré les questions pertinentes à poser. Nous avons également veillé à formuler des questions visant avant tout une meilleure compréhension du problème, plutôt que des solutions déjà envisagées. Nous avons en outre préparé la « Stakeholders list, stakeholders map and empathizing strategy » qui nous était demandée. Après nous être réparti le travail, chacun a pu avancer de son côté et réaliser sa part de la tâche. Le travail délivré se trouve en annexe de ce document.

Semaine 5

Un appel Teams avec Madame Christelle Felten ainsi que Justine Even a eu lieu le mercredi matin. Lors de cet échange, elles nous ont présenté les points clés du projet, leurs attentes à notre égard et les éléments essentiels à comprendre pour bien cerner le problème. Nous avons également convenu d'une visite sur place afin de mieux appréhender la situation. Plus tard dans la journée, nous nous sommes de nouveau réunis pour partager notre ressenti, mettre en commun nos questions et clarifier notre compréhension du projet. Nous avons aussi réfléchi aux personnes que nous pourrions interviewer lors de notre visite de l'hôpital, ainsi qu'aux questions les plus pertinentes à leur poser.

Semaine 6

Nous avons visité la Clinique Saint-Luc Bouge A.S.B.L. en compagnie de Madame Christelle Felten. Elle nous a expliqué concrètement les problématiques auxquelles elle est confrontée au quotidien. Elle nous a montré les différents plannings et nous a permis d'échanger directement avec les deux équipes de gestion de planning de chirurgie et d'orthopédie. Nous avons également pu interviewer des patients, ainsi que les deux chefs infirmiers du service d'orthopédie, afin de compléter notre compréhension du problème à tous les niveaux. Cette visite nous a permis de constater sur le terrain les difficultés rencontrées par les équipes et la manière dont elles sont actuellement gérées. Nous avons rapidement compris que le système actuel ne fonctionne que grâce à l'engagement des équipes, déjà très fortement sollicitées. Nous avons ensuite poursuivi le travail sur les livrables demandés. À la suite de la visite, notre compréhension du problème s'est nettement améliorée et nous avons pu compléter de manière plus précise l'empathy map, le résumé des interviews et la phase de définition. Le travail délivré se trouve en annexe de ce document.

Semaine 7

Cette semaine, le cours a porté sur la phase d'*Idéation* ainsi que sur le concept du *Business Model Canvas* (BMC). Nous avons également eu un entretien avec M. Geens, au cours duquel nous avons présenté l'avancement de nos travaux. À l'issue de cette réunion, la décision a été prise de retravailler la formulation de notre problème principal afin de le scinder en plusieurs sous-problèmes plus spécifiques. Cette orientation vise à faciliter l'analyse et à rendre le développement de solutions plus ciblé et pertinent.

Semaine 8

Nous nous sommes entretenus afin de retravailler notre problème. Nous avons décidé d'adopter une approche en trois temps en amont, pendant et en aval, afin de diviser ce problème principal en trois sous-problèmes plus ciblés et plus faciles à traiter.

Semaine 9

Durant cette semaine, les séances de cours ont abordé les volets liés au *Financing* et à la *Regulatory pathway*. À la suite de ces enseignements, notre équipe s'est réunie pour convenir d'une date de travail en présentiel, dédiée à la réflexion approfondie sur les trois sous-problèmes définis précédemment. L'objectif était d'établir un cadre structuré pour avancer efficacement dans la conception de pistes de solutions.

Semaine 10

Au cours de cette semaine, notre groupe s'est réuni afin de redéfinir le problème et de préciser trois sous-problèmes, formulés selon la méthode How Might We. Nous sommes ensuite passés à une phase d'idéation durant laquelle nous avons brainstormé collectivement pour générer un maximum d'idées, en mobilisant différentes techniques de créativité vues au cours. À l'issue de cette étape, nous avons opéré une phase de convergence en évaluant les idées selon les critères Desirable, Feasible et Viable (DFV), avant de sélectionner celles qui présentaient le plus fort potentiel. Pour chacune des solutions retenues, un Business Model Canvas a été élaboré afin d'en préciser la structure et la valeur ajoutée. Enfin, nous avons pris contact avec l'équipe hospitalière en vue d'organiser un appel visant à leur présenter nos propositions et à valider leur pertinence. En parallèle, nous leur avons transmis un prototype du site sur lequel nous travaillons pour recueillir leurs retours avant la prochaine itération.

Semaine 11

Nous avons eu une réunion de consultation avec le professeur Geens afin de faire le point sur notre projet. Nous avons également pu participer à l'événement Mind & Market, ce qui nous a permis d'acquérir de l'expérience en matière de pitch.

Semaine de Pâques 1

Une réunion a été organisée en milieu de semaine avec l'équipe de l'hôpital afin de lui présenter nos solutions. Celle-ci a apprécié la proposition, tant sur la forme que sur le fond. Un focus sur la solution Upstream a été demandé afin de parvenir à un résultat plus concret et plus précis.

Semaine de Pâques 2

Nous nous sommes réunis afin de revoir notre solution et de l'améliorer. Ce travail a été effectué en partie par François, qui possédait les compétences nécessaires pour répondre aux attentes de l'équipe hospitalière. Par ailleurs, nous avons travaillé sur une première version de notre pitch.

Semaine 12

Lors de cette semaine, nous nous sommes retrouvés afin de finaliser notre support de présentation. Nous avons également bénéficié d'une séance de coaching avec M. Néra, qui nous a fait un retour direct sur le fond et la forme de notre pitch. Enfin, François nous a partagé la dernière version du prototype pour la partie Upstream.

Semaine 13

Un test de notre prototype a été effectué à l'hôpital par François. L'équipe hospitalière a validé la solution que nous avons créée. Bien qu'elle reste perfectible, elle correspond à leurs attentes ; il reste à présent à étudier son intégration avec les logiciels déjà existants.

Prototyping testing

May 12, 2026

1 Prototyping

1.1 Upstream

For the upstream solution, our prototype consists of an interface with different features designed to help the staff manage bed planning.

We went through multiple iterations to obtain the optimal interface suited to the hospital staff's needs. We had our first meeting with them on April 22nd to present the first version of the platform. They provided us with valuable feedback to improve the tool. We worked on this feedback to modify the platform and add the features they requested. We then had a second meeting on May 15th to present the second version of the platform. They really appreciated the modifications we made. They once again provided feedback for further improvements, and we scheduled testing for May 11th with the third iteration of the project.

Voici le lien de la plateforme :<https://lord-melflam.github.io/saint-luc-bouges-g6-upstream-prototypes/>

1.2 During

To harmonize scheduling practices across units, we developed a solution focused on a shared and adaptable planning procedure. Our approach aims to maintain operational continuity even during key staff absences by standardizing methods across the different schedules. The solution consists of a global concept including shared templates and a centralized dashboard accessible to all staff members. This is supported by a clear backup system and improved coordination between units to ensure that planning remains smooth and error-free. By implementing a universal color-coding system and cross-training multiple members per unit, we ensure that the management of bed occupancy and patient flow is both transparent and resilient. This concept was selected through a DFV evaluation to ensure it meets the hospital's technical constraints and the staff's needs.

1.3 Downstream

For this part of the problem, we imagined a container placed in one of the green spaces around the hospital that would serve as a post-discharge waiting room.

Here are the prototypes generated by AI:



Figure 1: Outside view of the waiting room



Figure 2: Inside view of the waiting room

We presented this idea to the hospital staff during our meeting on April 22nd. They advised us to focus on the upstream solution because they did not have a large budget, and they considered it to be the more promising solution. However, we still produced a second version with a lower budget.



Figure 3: Low-budget version of the waiting room

2 Testing

François went to the hospital on May 11th to let the staff test our platform. Here is the feedback they gave us. (The meeting was conducted in French, so the feedback is also in French.)

Bons points:

- Système de Notification (bonne idée car soucis parfois des familles pas au courant, patient pas au courant, oubli de notifs de l'admin, etc) !!!!!!!
- Bien pour l'équilibrage de la repartition des lits et avoir une vue irl (argument de poids face aux medecins qui parfois n'en font qu'à leur tête) ... Autre chose est qu'on peut grace à l'outil préparer en avance et voir pour les fermetures de service si ça passe. Donc ça peut aider pour les fermetures

Points d'amélioration/de developpement supplémentaires après l'onboarding:

- Switch en Français (bouton en français)
- Chambre privée / differente des chambres standards. Soit flagger celui qui n'a pas le bon type de chambre par rapport à sademande et auto-assigner dès que libération du bon type (proposition logiciel. Celui qui a demandé)
- Les VIP Privées != premium. Même pour les lits premiums, parfois 2 patients request un lit premium, du ucoup là on pourrait se dire que le lit premium qui se libérera (s'il n'y en avait pas un à l'instant) serait attribué à celui qui avait fait la demande vant, mais appremment pour l'attribution du premium ça dépend aussi du statut du patient: SI c'est un médecin de profession qui est patient, ou un vétéran de guerre, etc is seront prioritaires par rapport à un patient lambda qui fait la requete du meme lit premium.
- LE SERVICE DES URGENCES, C'EST PAS UN SERVICE D'HOSPI -j. C'est un service d'entrée ou de transition. Donc la matérialisation actuelle en tant que service physique est incorrecte. Petit exemple: Un patient arrive aux urgences, il est admis et mis en entrée et attribué selon le type de procédure requise, un service approprié (urologie, etc ... ces services d'hospitalisation en faite)
- Patient suite des entree electives ou suite à un patient des urgences.

- Voir pour communication avec les logicielles existants dans l'hôpital
- Alerte quand taux d'occupation arrive en dessous d'un seuil, suggérer des actions (fermétudes, etc...)
- Dans les petits blocs, nom + prenom + date de naissance -; Et dès que clic, ajouter au panel à coté les informations complètes du patient sur lequel on a cliqué
- Bloquer forecasting en fonction des champs obligatoires ou non-obligatoires (obligatoires doivent etre absolument remplis, non obligatoires ou optionnels, pas spécialement)
- Personnaliser en fonction du type d'intervention, la couleur des cartions, etc ... Code couleur fiable au système actuel ou modulable (jaune, orange, rouge, bleu, etc...), donc tel type de prodédure, tel code couleur qui fit à leur utilisation actuelle
- Rdv post stop: Notif ou petit "v" pour "right" du check que le dossier est complet ou petit point d'exclamation si incomplet et nécessite une attention

MISE EN PLACE DE LA FORMATION "PLANIFICATION PARTAGÉE"

Objectif de la formation

Former le personnel de planification et les membres de renfort (backups) à la nouvelle procédure de planification standardisée, afin que la gestion des lits reste fluide et sans erreurs, même lors de l'absence d'une cheffe de planning.

Public Cible

- **Principal** : Cheffes de planning par unité.
- **Secondaire** : Personnel de backup désigné (plusieurs membres formés par unité) et cadres de santé.

Format de la Formation (Blended Learning)

- **Théorie & Démonstration** : Modules asynchrones en ligne comprenant des vidéos explicatives de la procédure.
- **Pratique** : Exercices sur le tableau numérique partagé en temps réel.
- **Soutien continu** : Mise à disposition d'une checklist des tâches essentielles et de templates prédéfinis.

Outils et Ressources à Préparer

- Le tableau numérique partagé finalisé.
- Le document détaillant le système de codage couleur universel (urgences, priorités, absences).
- La checklist des tâches pour éviter les erreurs.
- Les vidéos tutoriels enregistrées via capture d'écran de l'outil numérique.

PROTOTYPE SIMPLE DES COURS EN LIGNE (Interface type e-learning)

Titre du cours : Maîtrise de la Planification Partagée et Gestion des Backups

Durée estimée : 1h30

Prérequis : Avoir ses accès au tableau numérique de l'hôpital.

MODULE 1 : Introduction à la nouvelle planification (15 min)

- **Vidéo 1.1** : Pourquoi harmoniser nos pratiques ? (Les défis actuels, l'importance de la coordination inter-unités et la prévention des tensions liées aux absences).
- **Document à télécharger** : La vision globale du processus "During".

MODULE 2 : Le Tableau Numérique Partagé et ses Règles (30 min)

- **Vidéo 2.1** : Découverte de l'interface centralisée (Comment éviter les déplacements multiples pour consulter les 3 plannings).
- **Vidéo 2.2** : Utiliser les templates de planning prédéfinis.
- **Vidéo 2.3** : Le codage couleur universel (Comment identifier d'un coup d'œil les priorités, les tâches urgentes et les absences).
- **Exercice interactif** : Assigner le bon code couleur à 3 profils de patients fictifs.

MODULE 3 : Le Protocole de Remplacement "Backup" (20 min)

- **Vidéo 3.1** : Que faire quand la personne clé est absente ? (Le rôle du backup désigné).
- **Outil interactif** : Découverte pas-à-pas de la Checklist des tâches essentielles de planification.
- **Quiz d'évaluation** : 5 questions pour s'assurer qu'aucune étape cruciale n'est oubliée lors d'un remplacement.

MODULE 4 : Coordination et Communication Quotidienne (15 min)

- **Vidéo 4.1** : Les réunions courtes de coordination inter-unités (Comment anticiper les moments de tension en termes d'occupation de lits).
- **Vidéo 4.2** : L'intégration des données "Upstream" (Prédiction des sorties) dans votre tableau quotidien pour mieux anticiper.

MODULE 5 : Validation et Pratique (10 min)

- **Simulation finale** : Cas pratique d'une matinée chargée avec une absence soudaine d'un collègue. Vous devez mettre à jour le tableau et utiliser la checklist.
- **Certificat d'achèvement** et accès permanent au forum de questions/réponses inter-unités.

Ideation

Group Project 6

15 avril 2026

1 Ideation

As we have three sub-problems to tackle, we have decided to explore three different ideation methods. This gave us the opportunity to familiarise ourselves with and practise various brainstorming techniques.

1.1 Upstream

1.1.1 Upstream challenge statement

"How might we better predict the length of stay and improve communication with patients about their care pathway, in order to anticipate hospital discharge earlier and more accurately?"

Here, we focus on reducing uncertainty before discharge by combining better anticipation with clearer patient communication.

1.1.2 Why this ideation method

For this sub-problem, I used **Morphological Analysis (Morphological Matrix)** because it is a structured ideation method that :

- fits the **diverge then converge** logic from the course ideation framework,
- allows rapid generation of many realistic combinations,
- is well adapted to a systems-oriented/engineering approach.

This method is presented in our course material (W7 Ideation) as a structured way to explore solution spaces by combining key dimensions of a problem.

1.1.3 Ideation setup (Morphological Matrix)

I explored combinations across four dimensions :

1. **Inputs for anticipation** : historical LOS, diagnosis/procedure type, social discharge constraints
2. **Prediction approach** : simple rules, risk score, advanced ML
3. **Communication channel** : nurse script, printed pathway sheet, SMS reminder
4. **Update timing** : admission, D-2, D-1, day of discharge

This produced multiple candidate concepts, then narrowed down through DFV scoring.

1.1.4 Convergence with DFV

Pivot decision : Replace concept B (advanced ML, low feasibility/viability now) with a lighter and deployable alternative : concept A (simple score + confidence + daily update).

Concept	Desirable	Feasible	Viable	Total
A. Simple LOS score + confidence level	4	5	5	14
B. Advanced ML prediction model	3	2	2	7
C. Discharge checklist from admission	4	5	4	13
D. Automated SMS communication journey	4	3	3	10
E. Shared unit dashboard for expected discharges	5	4	4	13
F. Daily 10-minute discharge huddle	4	5	5	14

1.1.5 Final upstream concept

Early Discharge Forecast & Communication Bundle

Three integrated components :

1. **Early forecast at admission** : estimated discharge date + confidence level.
2. **Daily update ritual** : short team huddle to confirm/adjust expected discharges.
3. **Standardized patient communication** : clear milestone updates on expected pathway (D-2, D-1, discharge day).

1.1.6 Why this concept is robust

- **Desirable** : improves visibility for teams and transparency for patients/families.
- **Feasible** : low technical burden, compatible with current operations.
- **Viable** : limited implementation cost, scalable unit by unit.

1.1.7 Risks and mitigation

- **Risk** : low team adoption.
Mitigation : one owner per unit + fixed 10-minute daily ritual.
- **Risk** : prediction errors.
Mitigation : confidence levels + mandatory daily reassessment.
- **Risk** : communication inconsistency.
Mitigation : standard communication template for all units.

1.1.8 Expected impact (KPIs)

- Improved discharge date prediction accuracy.
- Higher share of patients informed at least 24h in advance.
- Fewer last-minute discharge delays and reduced bed-flow friction.

1.1.9 Prototype developed (how, why, and goal)

To move from concept to action, I developed a small prototype stack in Python + web :

- **los_forecast.py** : a lightweight LOS prediction engine with a confidence level and an early-coordination flag.
- **daily_huddle_board.py** : an operational board generator to support daily team alignment around expected discharges and blockers.
- **communication_flow.py** : a D-2 / D-1 / D0 communication scheduler to standardize patient updates.
- **Web demo (index.html)** : an interactive interface to present the logic and discuss decisions with non-technical stakeholders.

How it was developed The prototype was built iteratively from the selected upstream concept :

1. define simple and explainable prediction rules,
2. transform output into operational decision support (huddle board),
3. connect prediction to patient communication milestones,
4. package the result in a publishable web demo for team reviews.

Why this prototype This approach was chosen to remain realistic in the current project scope :

- no heavy infrastructure,
- transparent logic for clinical discussion,
- fast iteration cycles for group feedback.

Goal of the prototype The goal is not to deliver a final hospital system, but to provide a **credible proof of feasibility** for the upstream strategy :

- anticipate discharge earlier,
- improve coordination before the discharge day,
- improve communication consistency with patients.

Prototype here : <https://lord-melflam.github.io/saint-luc-bouges-g6-upstream-prototypes/>

1.2 During

How might we harmonize scheduling practices across units through a shared and adaptable procedure, so that planning can still be completed smoothly even when one or more key staff members are absent ?

1.2.1 BRAINSTORMING METHOD

Afin de traiter ce sous-problème, nous avons opté pour une méthode de brainstorming structuré. Ce choix s'explique par le fait que le processus de planification ne résulte pas d'une cause unique, mais d'un ensemble de facteurs interconnectés : pratiques de planification différentes entre les unités, difficulté de remplacement du personnel clé, et nécessité de coordonner plusieurs parties prenantes dans un environnement hospitalier complexe.

Conformément à l'approche design thinking enseignée en cours, nous avons d'abord procédé à une phase de *divergence* en générant un maximum d'idées sans jugement prématuré, avant de passer à une phase de *convergence* pour sélectionner les options les plus pertinentes et réalistes.

1.2.2 IDÉES GÉNÉRÉES

- Créer un tableau de planification partagé accessible à l'ensemble du personnel concerné en temps réel, assurant la visibilité des emplois du temps même en cas d'absence.
- Standardiser le processus de planification entre unités avec une structure commune et des règles claires et procéder à la mise en place de vidéo explicatives.
- Définir un protocole de remplacement pour les rôles clés en cas d'absence d'un ou plusieurs membres du personnel.
- Mettre en place des réunions de coordination courtes entre unités pour anticiper les absences et moment de tension en terme d'occupation de lits.
- Implémenter un système de codage couleur simple universel pour identifier priorités, tâches urgentes et absences de personnel.
- Former plusieurs membres par unité à la gestion du planning.
- Centraliser l'information de planification en un lieu unique pour éviter les déplacements multiples et/ou avoir en place un dashboard complet et accessible par tous.
- Élaborer une checklist des tâches essentielles de planification afin de s'assurer qu'aucunes erreurs ne soit faites.
- Créer des templates de planning prédéfinis

1.2.3 ÉVALUATION

Nous avons ensuite évalué chaque idée selon les trois piliers du design thinking : *desirability* (utilité pour les utilisateurs), *feasibility* (faisabilité technique et organisationnelle), et *viability* (rentabilité par rapport aux ressources investies). Cette grille d'évaluation a permis de distinguer les solutions réalistes dans le contexte hospitalier.

1.2.4 CONVERGENCE

Après ce tri, nous avons conservé les idées les plus prometteuses et les avons regroupées en un concept solution global : créer des templates et une procédure de planification partagée et adaptable, soutenue par un système de backup clair et une coordination améliorée entre unités avec donc une normalisation des méthodes entre les 3 plannings. Cette solution s'avère la plus cohérente avec les contraintes observées lors des visites terrain et les besoins exprimés par les acteurs.

1.3 Downstream

How might we organize an intermediate solution after discharge so that patients can be relocated quickly, allowing rooms to be freed earlier while maintaining the quality and continuity of care ?

1.3.1 Brainstorming method

For this subproblem, we decided to use the SCAMPER method. We made this choice because for this part of the problem, a solution immediately sprang to mind. We wanted to make sure we didn't get stuck with just that one idea, so the SCAMPER method is a good way of forcing ourselves to think of solutions we wouldn't have thought of naturally.

1.3.2 Divergence : SCAMPER 7 pillars

SUBSTITUTE

- Replace the hospital bed with a comfortable medical chair or armchair in a dedicated waiting area (the patient no longer needs a bed but a place to rest)
- Replace passive waiting with a mobile app that automatically notifies the patient's family member as soon as discharge is confirmed, reducing waiting times
- Replace the nurse with a receptionist dedicated to managing discharges
- Replace transport provided by a relative with a taxi or private hire service approved by the hospital
- Replace the room with one from another, less busy ward ; this allows a new patient requiring care to be admitted to the ward, whilst the patient who is due to be discharged is no longer receiving care and can therefore wait anywhere.

COMBINE

- Combine the hospital cafeteria with a post-discharge waiting area (where patients can wait in comfort whilst eating)
- Combine a post-discharge recovery room with services such as television, Wi-Fi and magazines to make the wait more pleasant and encourage patients to leave their rooms
- Suggest to patients that they book their medical appointments on the day they are discharged from hospital. That way, when they leave their ward, they can go straight to their appointment and vacate their room.

ADAPT

- Adapting the concept of the airport business lounge : a comfortable VIP lounge where patients who have been discharged from hospital can wait for their transport in comfortable surroundings
- Adapting the Uber model : an on-demand transport platform specifically for patients being discharged, triggered automatically upon confirmation of discharge
- Adapt the click-and-collect system : the customer "books" a pick-up slot and receives a notification when their delivery is ready
- Adapting the Japanese capsule hotel model : minimalist yet comfortable rest areas where guests can wait without taking up a whole room

MODIFY

- Enhance communication by sending daily reminders to relatives regarding the scheduled discharge time the day before and on the morning of discharge
- Modify the definition of 'discharge' : consider a patient to have been discharged as soon as they leave their room, even if they are still waiting within the hospital

- Strengthen the role of relatives by involving them in the discharge planning process from the moment of admission (availability agreement)
- Adjust timetables : introduce standardised departure times (e.g. 9am, 11am, 2pm) to improve transport coordination
- Change the departure time, bring it earlier

PUT TO ANOTHER USE

- Use existing waiting rooms (outpatient departments) as post-discharge reception areas during off-peak hours
- Use under-utilised spaces in the hospital to convert them into waiting rooms
- Using hospital volunteers to support and keep patients company whilst they recover
- Convert part of the hospital car park into a dedicated pick-up area with a comfortable shelter

ELIMINATE

- Eliminate the requirement to go through the check-in area for departure formalities (have documents signed in a dedicated departure area)
- Eliminate reliance on family members as the sole means of transport (by offering systematic alternatives)
- Eliminate certain parts of the process to speed it up, such as unnecessary morning visits to the doctor
- Eliminate uncertainty about the time of departure by introducing an algorithmic prediction of the departure time the day before
- Eliminate the ward as a waiting area following discharge by introducing a clear institutional rule : the ward must be vacated X minutes after the medical decision has been made

REVERSE

- Reorganize the process : prepare the patient for discharge the day before to speed up their departure on the day itself.
- Reverse the logic : it is the transport service that adapts to the patient, the relative receives an alert and must be there within a specified time, otherwise an alternative transport service is automatically arranged.
- Flip the responsibility : it is the hospital that takes charge of coordinating transport, not the patient.
- Reverse the notification process : instead of the patient calling their relative, the hospital system notifies the relative directly at the appropriate time.
- Reordering priorities : the most in-demand rooms are given priority under an accelerated check-out procedure

1.3.3 Convergence with DFV

To identify the most promising ideas generated during the SCAMPER brainstorming session, we applied the DFV (Desirable, Feasible, Viable) convergence model. Each idea was evaluated against three criteria : whether it is desirable for the patient, whether it is feasible in a real hospital context, and whether it is viable for the hospital. Only ideas meeting all three criteria were retained. Due to the large number of solutions, this table is available in the [Appendix A](#).

The selected ideas form a coherent whole centered on **three main areas** :

- A post-discharge waiting area : comfortable chairs, lounge, refurbished spaces, volunteers, car park pick-up zone.
- Improved digital coordination : notification app, prediction algorithm, click-and-collect system, direct notifications to relatives.
- A reorganization of the discharge process : preparation the day before, redefinition of discharge procedures, institutional guidelines, automatic alternative transport.

A Appendix A : DFV table of Downstream solutions

Idea	Desirable	Feasible	Viable	Keep ?
Replace bed with comfortable chair in dedicated waiting area	✓	✓	✓	✓
Mobile app notifying family upon discharge confirmation	✓	✓	✓	✓
Receptionist dedicated to managing discharges	✓	✓	✗	✗
Hospital-approved taxi/private hire service	✓	✓	✓	✓
Move patient to a less busy ward to free up the room	✗	✗	✗	✗
Combine cafeteria with post-discharge waiting area	✓	✓	✓	✓
Post-discharge lounge with TV, Wi-Fi, magazines	✓	✓	✓	✓
Book follow-up appointment on discharge day to vacate room	~	✗	~	✗
Airport business lounge concept	✓	~	~	✗
On-demand transport platform (Uber model)	✓	✓	✓	✓
Click-and-collect pick-up slot system for relatives	✓	✓	✓	✓
Japanese capsule hotel model (minimalist rest pods)	✓	✗	✗	✗
Daily reminders to relatives about discharge time	✓	✓	✓	✓
Redefine “discharge” as leaving the room, not the hospital	✓	✓	✓	✓
Involve relatives in discharge planning from admission	✓	✓	✓	✓
Standardised departure time slots (9am, 11am, 2pm)	~	~	✓	✗
Bring forward departure time	~	~	✓	✗
Use existing outpatient waiting rooms during off-peak hours	✓	✓	✓	✓
Convert underused hospital spaces into waiting areas	✓	✓	✓	✓
Hospital volunteers to accompany waiting patients	✓	✓	✓	✓
Dedicated pick-up area in car park with shelter	✓	✓	✓	✓
Sign discharge documents in a dedicated departure area	✓	✓	✓	✓

Idea	Desirable	Feasible	Viable	Keep ?
Eliminate reliance on family as sole transport option	✓	✓	✓	✓
Eliminate unnecessary morning doctor rounds	~	✗	~	✗
Algorithmic prediction of discharge time	✓	✓	✓	✓
Institutional rule : room vacated X min after medical decision	✓	✓	✓	✓
Prepare patient for discharge the day before	✓	✓	✓	✓
Transport adapts to patient, auto-booking if relative late	✓	✓	✓	✓
Hospital coordinates transport instead of patient	✓	✓	~	~
Hospital system notifies relative directly	✓	✓	✓	✓
Accelerated check-out for highest-demand rooms	✓	✓	✓	✓

TABLE 1: DFV convergence model applied to SCAMPER ideas

DOWNSTREAM - SOLUTION INTERMÉDIAIRE POST-SORTIE (SCAMPER + DFV)

Partenaires clés	Activités clés	Proposition de valeur	Relations clients	Segments clients
- Société transport VTC/taxi agréé - Bénévoles hospitaliers - Direction hospitalière (règle institutionnelle) - IT interne (app et dashboard)	Axe 1 — Zone physique - Gestion et animation de la zone d'attente post-sortie - Coordination des volontaires sur site - Gestion de la zone de pickup voiture Axe 2 — Digital - Notification automatique des proches à la confirmation de sortie - Prédiction algorithmique de l'heure de sortie - Système click-and-collect pour réserver le créneau de pickup Axe 3 — Process - Préparation de la sortie la veille (documents, transport) - Application de la règle institutionnelle de libération de chambre - Déclenchement automatique du transport alternatif si famille en retard	Responsable de flux - Libération plus rapide des chambres - Meilleure rotation et disponibilité des lits Cadre infirmier - Processus de sortie clair et standardisé - Moins de gestion ad hoc des cas complexes Patient sortant - Attente post-sortie digne et confortable - Information proactive sur l'heure de sortie	- Protocole institutionnel ancré : chambre libérée X min après décision médicale - Coordination automatisée avec la famille via l'app - Présence de volontaires pour accompagner l'attente	Principal - Responsable de flux / gestionnaire de lits Secondaires - Cadre infirmier de l'unité - Patient sortant et famille
Ressources clés		Canaux		
- Algorithme de prédiction de l'heure de sortie - Application mobile de notification - Espaces hospitaliers sous-utilisés reconvertis en zone d'attente - Volontaires hospitaliers formés - Protocole institutionnel de sortie formalisé - Zone de pickup dédiée dans le parking		- Application mobile (notification proches + click-and-collect) - Dashboard interne coordination des sorties - Espace physique dédié post-sortie - Zone de pickup voiture aménagée		
Structure de coûts		Flux de revenus / gains		
- Aménagement et entretien de la zone d'attente - Développement et déploiement de l'application - Formation et coordination des volontaires - Coût du transport alternatif subventionné - Maintenance du dashboard et de l'algorithme		- Réduction du temps de blocage de lit post-décision médicale - Augmentation du nombre de lits disponibles par jour - Fluidification du flux global d'admission/sortie - Réduction du stress soignant lié aux sorties tardives - Amélioration du confort et de l'expérience patient en sortie		

DURING - TEMPLATES & PROCÉDURE PARTAGÉE DE PLANIFICATION (Brainstorming structuré)

Partenaires clés	Activités clés	Proposition de valeur	Relations clients	Segments clients
- Direction RH (gestion absences) - Cadres de santé par unité - Direction médicale (légitimité)	- Création et maintenance des templates de planning - Formation des membres backup à la procédure partagée - Réunions courtes de coordination inter-unités - Mise à jour et diffusion des checklists - Déploiement du tableau numérique partagé - Intégration du template de formation Upstream dans l'onboarding planning - Partage transversal des connaissances entre unités via la procédure commune	Continuité - Planning opérationnel même sans la personne clé - Procédure claire accessible à tous Simplification - Tout le monde sait quoi faire, quand, comment - Réduction de la charge cognitive et du stress	- Formation initiale à la procédure et aux templates - Réunions récurrentes courtes de coordination - Checklist comme filet de sécurité permanent	Principal - Cheffe planning par unité - Personnel de backup désigné
Ressources clés		Canaux		
- Templates de planning prédéfinis - Procédure partagée documentée - Codage couleur universel inter-unités - Personnel backup formé par unité - IT interne (outil numérique) - Template de formation solution Upstream		- Tableau numérique partagé en temps réel - Vidéos explicatives de la procédure - Réunions courtes inter-unités		
Structure de coûts		Flux de revenus / gains		
- Temps de création des templates et de la procédure - Formation initiale des équipes et des backups - Déploiement et maintenance de l'outil numérique partagé - Temps de réunions récurrentes inter-unités		- Réduction du temps perdu en cas d'absence clé - Moins d'erreurs de planification inter-unités - Meilleure anticipation des tensions de lits - Réduction du stress d'équipe en situation d'absence - Capitalisation des connaissances Upstream dans le planning		

⇒ Mis les activités de la solution upstream en vert

UPSTREAM - EARLY DISCHARGE FORECAST & COMMUNICATION BUNDLE (Analyse morphologique)

Partenaires clés	Activités clés	Proposition de valeur	Relations clients	Segments clients
- Cadres de santé (adoption) - Système d'info patient existant - Direction médicale (légitimité)	- Prédiction de date de sortie à l'admission + niveau de confiance - Animation de la RU quotidienne (10 min/unité) - Communication patient aux jalons J-2, J-1, J0 - Mise à jour et réajustement quotidien du score - Suivi des écarts prédiction / sortie réelle	Chef d'unité (principal) - Anticipation des sorties dès l'admission - Peu de surprises de dernière minute - Planning maîtrisé et ajustable Patient (secondaire) - Visibilité sur son parcours de soins	- Adoption progressive unité par unité - Owner dédié par unité - Rituel ancré dans la routine quotidienne	Principal - Chef d'unité hospitalière - Infirmière coordinatrice Secondaire - Patient et famille
Ressources clés		Canaux		
- Données historiques de séjour - Règles de scoring simples - Templates de communication standardisés - Owner désigné par unité (basé sur les 2 unités visitées) - IT hospitalier (ressource interne)		- Dashboard interne partagé par unité - Réunion d'unité présentielle quotidienne - SMS ou fiche imprimée patient		
Structure de coûts		Flux de revenus / gains		
- Formation des équipes soignantes (lié avec notre solution DURING (voir BMC 2)) - Déploiement et maintenance du dashboard - Coût marginal des SMS patients - Temps d'animation (RU ~10 min/j/unité)		- Augmentation du taux de sorties planifiées vs tardives - Réduction du temps de blocage de lit post-décision médicale - Meilleure visualisation du flux pour l'équipe soignante (réduction du stress) - Patients mieux informés sur leur parcours (confort et sérénité accrus)		

Annexe 1: Stakeholders list, stakeholders map and empathizing strategy

Group 6: Maurine Poncelet, François Meli, Lheo Rary, Jabrane Mouhtadi

1 Stakeholders list



Figure 1: Stakeholders identified in the project

2 Stakeholders map

Based on the CLIP stakeholder's classification, we ranked the different stakeholders into categories.

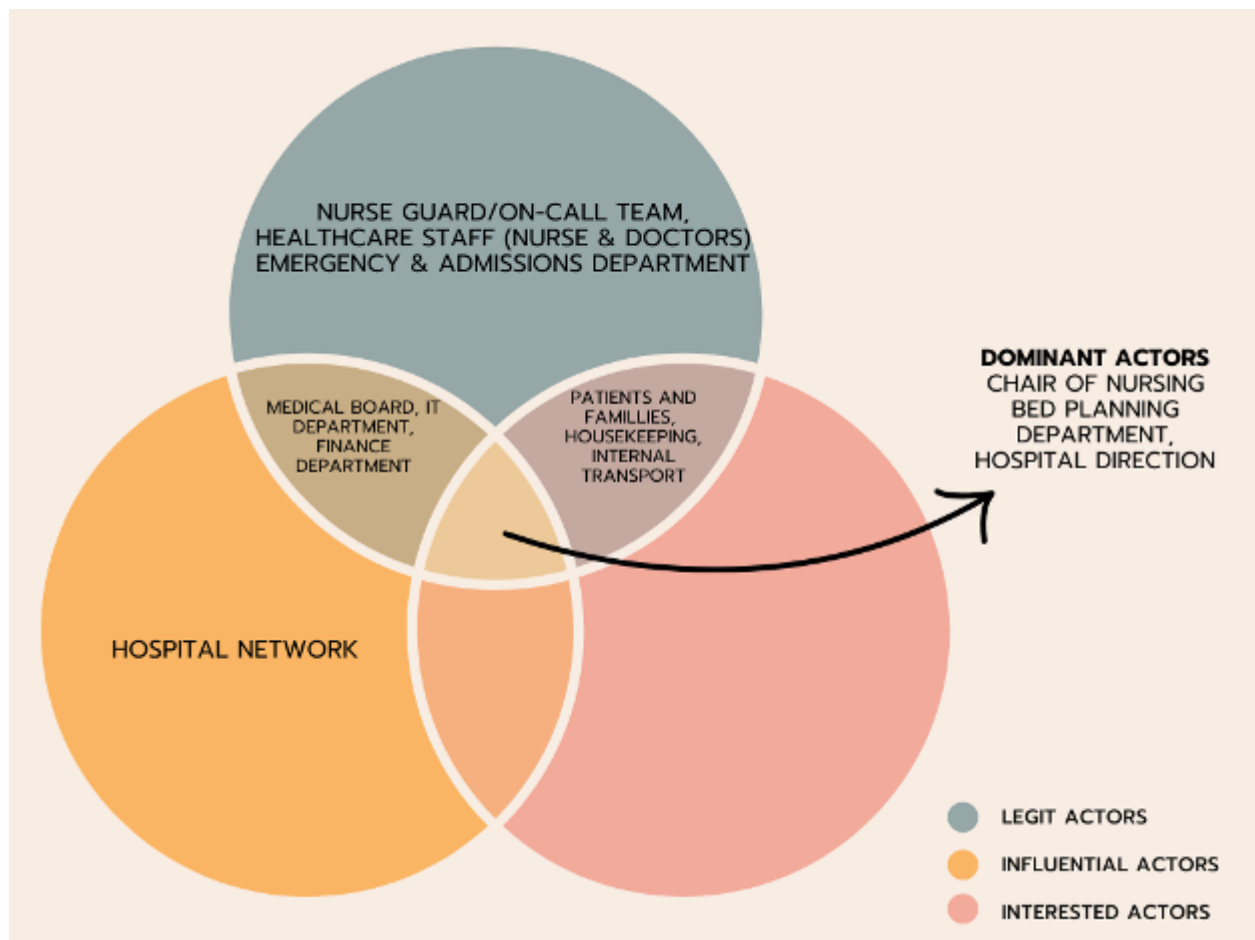


Figure 2: CLIP-based stakeholder map (legit, influential and interested actors)

Dominant Actors (High Power / High Interest)

- Chair of Nursing and Allied Services (Carol-Anne Jablonowski): Project leader with the formal authority to implement new nursing protocols.
- Bed Planning Department: They are at the heart of the daily struggle; they have the mandate to manage flow and a high interest in reducing “random occupancy.”
- Hospital Direction: They provide strategic mandate and resources. They want the stable occupancy rate mentioned in the project goals.

Influential Actors (High Power / Low to Medium Interest)

- Medical Board: Since discharge is a medical decision, their agreement is mandatory for any new rule. They have high power but might have lower interest in “logistics” unless it improves their clinical work.
- IT Department: They hold technical power. Without their collaboration, the “optimization” (dashboards or tracking tools) cannot be realized.
- Finance Department: They have the power of the budget. They care about the “cost of unused beds,” but they are not involved in the day-to-day nursing process.

Respected / Legit Actors (Medium Power / High Interest)

- Nurse Guard / On-call Team: They deal with the “refusals” from units every day. They have the experience to say what is realistic.
- Healthcare Staff (Nurses & Doctors): They are the ones who “justify refusals.” Their interest is high because the current process is “time-consuming,” but they might resist if they feel more pressure.
- Emergency & Admissions Departments: They are the “victims” of the current bottleneck. They have high legitimacy in demanding a faster bed turnaround.

Vulnerable / Passive Actors (Low Power / High Interest)

- Patients and Their Families: They suffer from delays in discharge papers or lack of rooms, but they are not part of the decision-making process.
- Housekeeping (Room Cleaning): They are often blamed for delays but usually just follow orders. They have a high interest in a more “predictable” cleaning schedule.
- Internal Transport / Porters: Their efficiency depends on a process they don’t control.

Marginalized / Non-Actors (Low Power / Low Interest)

- Hospital Network (Réseau Namurois): While the clinic is part of this network, they are currently external to this specific internal process optimization, unless the project scales up to a regional level.

3 Empathizing Choices to Interview

Patients and their Families (Vulnerable)

They are the most impacted by delays but have no power; empathizing with them reveals the “human cost” of inefficient discharge (waiting in corridors, stress of transport).

Housekeeping / Room Cleaning (Marginal)

Often overlooked in strategic meetings, they are the physical bottleneck; understanding their constraints is key to reducing the time between a patient leaving and a bed becoming available.

Healthcare Staff: Nurses & Assistants (Respected)

They are the “legitimate” actors on the field; you must understand their reasons for “refusing” beds (fear of workload, lack of trust) to ensure they adopt your future solution.

Bed Planning Department (Dominant)

They hold the formal mandate to manage flow but suffer from poor data; empathy helps identify the “informal signals” they use to guess bed availability in a chaotic system.

Medical Board / Senior Doctors (Powerful)

They have the ultimate power to sign discharge papers; understanding their clinical priorities and why they might delay a discharge is essential to change the overall process rules.

4 Progress status

We secured an interview on Wednesday, 4 March with two important stakeholders:

- Ms. Felten (Planning Manager): She represents the Bed Planning Department.
CLIP Category: Dominant.
Why: She has the formal mandate and the data. She is the one struggling with “supply and demand” daily.
- Ms. Even (Deputy Director of Nursing): She represents the Nursing Management.
CLIP Category: Powerful.
Why: She has the authority to change nursing protocols and rules across all sectors. She is the link between Carol-Anne’s strategy and the ward reality.

By interviewing Ms. Felten and Ms. Even (Powerful), we get the “system” perspective. Their positions allow us to understand the viewpoint of dominant and powerful stakeholders within the organization. To further strengthen our empathizing approach, we would also like to interview the staff, considered a respected stakeholder, as well as the housekeeping team, viewed as a more marginal stakeholder. These additional interviews would provide a “reality-based” perspective and enrich our overall understanding.

5 Empathy Strategy: Solving the assumption, time-consuming & refusals

The goal is to bridge the gap between official management data and the daily reality of the wards.

1. Top-Down Approach (Remote Interview - March 4th)

- Stakeholders: Ms. Felten (Dominant) and Ms. Even (Powerful).
- Objective: Define what “time-consuming” means at the management level. We want to identify administrative bottlenecks (e.g., constant phone negotiations, manual data entry).
- Key Focus: Understand why current planning feels “random” from their perspective and establish KPIs (e.g., relocation rates, bed turnaround time) to measure the problem.

2. Bottom-Up Approach (Planned On-Site Visit)

- Stakeholders: Nurses (Respected) and Housekeeping/Patients (Marginal/Vulnerable).
- Objective: Validate the “justifications for refusal.” We need to see if units block beds due to real workload issues, lack of tools, or a lack of trust in the central system.
- Key Focus: Uncover the physical reasons for “random” occupancy (e.g., waiting for doctors’ signatures, families arriving late, or cleaning delays).

By comparing the Dominant/Powerful view (the “System”) with the Respected/Vulnerable view (the “Reality”), you will identify exactly where the process breaks down. This ensures your solution isn’t just a top-down order, but a tool that actually saves time for the staff on the ground.

6 Mysteries to Solve (The Unknowns)

Information missing from the documents that we need to uncover during interviews.

- The “Notification” Mystery: How does the Planning Dept. actually find out a bed is free? Is there a real-time digital update, or do they rely on manual phone calls from nurses?
- The “Hidden Language” Mystery: Why do justifications for refusal vary by unit? Is there an “informal code” (e.g., claiming a bed is “broken” or “reserved”) used by staff to control their own workload?
- The “Morning Gap” Mystery: Why is anticipation difficult? Does the delay come from the doctor’s late rounds, the family’s availability to pick up the patient, or the wait for transport/ambulance?
- What is the official trigger/message that confirms that a room is ready for a new patient, is it digital or does it go by telephonic confirmation?

7 Real Problems to Understand (The Pain Points)

Identifying exactly why the process is “time-consuming” and “random.”

- The Negotiation Burden: How many phone calls does the Planning Dept. (Ms. Felten) make per day just to “beg” for a bed? Is the issue a lack of beds or a lack of visibility?
- Conflicting Interests: The Planning Dept. wants 100% occupancy (efficiency), while the Ward Nurses want a manageable patient-to-nurse ratio (safety). How is this tension resolved daily?
- The Turnover Bottleneck: Is “time-consuming” actually the gap between a patient leaving and the room being cleaned? Does Housekeeping know immediately when a patient has left?
- What are the criteria used to settle when conflicts arise between occupancy goals and actual unit capacity?
- Is there data available to identify occupancy patterns?

8 Hypotheses to Validate (The Assumptions)

At the end of the interview, not at the beginning. Theories we suspect are true but need to confirm on-site.

- Hypothesis 1 (Behavioral): “Units ‘hide’ beds or delay announcing departures to protect themselves from receiving difficult new patients or being overwhelmed.”
- Hypothesis 2 (Technical): “The current software is too complex or disconnected from the field, leading staff to manage everything via phone/paper instead of the digital system.”
- Hypothesis 3 (Structural): “Relocations happen because the hospital lacks a clear ‘buffer’ zone, forcing patients into the wrong sectors when discharge timing is missed.”
- Hypothesis 4 (Communication): “Frontline staff don’t see the financial impact of an empty bed; they see it as a much-needed break, creating a misalignment with Management goals.”

9 Interview Questionnaire to Discover Information, Verify Real Problems, and Test Our Hypotheses

- What are the current methods being used?
- How is the planning of discharges and admissions organized?
- What impact do these problems have on quality of care and patient satisfaction?
- Which improvements would you consider the highest priority?
- Have you already tested any solutions to optimize bed management? If yes, which ones? If not, why not?

Annexe 2 :Deliverable 2

Group Project 6

Mars 2026

1 Problem definition

Notre problème est formulé comme suit : « How might we optimize and harmonize patient discharge timing and bed allocation across units so that beds are freed early enough in the day to be reused, while maintaining quality of care and respecting each unit's clinical and organizational constraints? ».

Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur deux des six outils proposés dans le cours de *problem definition*, à savoir le diagramme d'Ishikawa et la méthode des 5 Why's, qui font partie des méthodes recommandées pour passer des symptômes aux causes profondes. Le diagramme d'Ishikawa nous a permis de structurer de manière systématique l'ensemble des facteurs contribuant au problème et de visualiser la nature multifactorielle des retards de sortie et des déséquilibres d'occupation des lits. La méthode des 5 Why's nous a ensuite servi à approfondir certains *pain points* observés sur le terrain, en remontant de « pourquoi » en « pourquoi » jusqu'à des causes racines actionnables. C'est la combinaison de ces deux approches qui nous a permis de reformuler une problématique centrale, à la fois suffisamment précise pour guider l'idéation et assez ouverte pour laisser place à plusieurs solutions possibles.

2 Résultat de nos entretiens

2.1 Visite – planning chirurgie

La planification se fait au jour le jour à l'aide d'un système de tableaux fixés au mur et de petits cartons comprenant des informations sur les patients. La planification du week-end se fait le vendredi. La liste des lits disponibles est envoyée en fin de journée au service des urgences afin qu'il sache où placer les patients arrivant en soirée ainsi que durant le week-end.

Il y a deux tableaux principaux :

- **Le tableau des futures hospitalisations** : il comprend toutes les dates futures, sur plusieurs mois à l'avance. Le tableau commence le dimanche et se termine le vendredi. Les hospitalisations programmées pour une opération ne se font au maximum qu'un jour à l'avance et commencent le lundi, il n'est donc pas nécessaire d'y intégrer le samedi. Pour chaque date, on retrouve les cartons représentant les patients dont l'hospitalisation est planifiée ce jour-là.
- **Le tableau des hospitalisations actuelles** : il reprend l'ensemble des lits du service et la répartition des patients dans ces lits. On voit rapidement que toutes les chambres sont remplies et que les places sont rares. À prendre en compte : il existe par étage deux chambres « tampons » qui ne devraient être utilisées qu'en cas de grand besoin ; malheureusement, celles-ci sont utilisées assez fréquemment.

Sur les cartons des patients figurent de nombreuses informations. Un code couleur est utilisé selon la spécialité (orthopédie, chirurgie esthétique, etc.) et/ou le nom du médecin. On y retrouve notamment : le nom du patient, sa date de naissance, le droit éventuel à une chambre individuelle, ainsi que d'autres informations pertinentes.

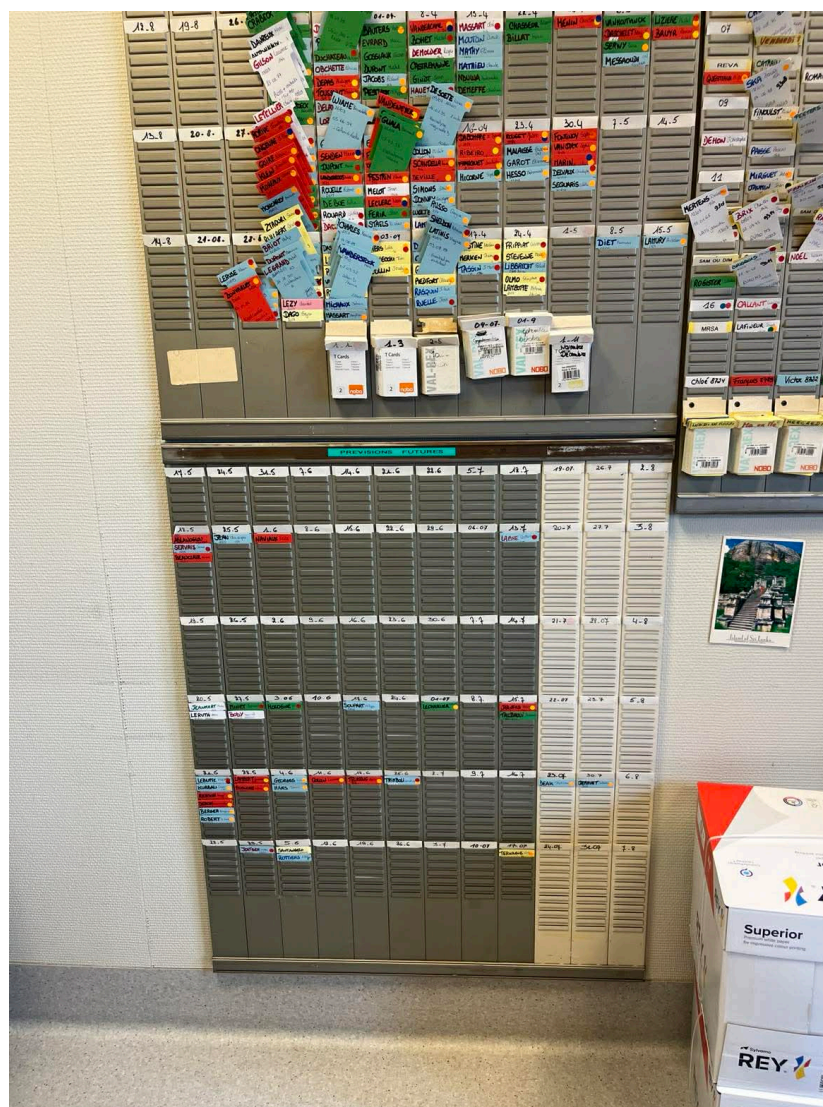


Figure 1: Exemple de tableau des futures hospitalisations

2.2 Visite – planning orthopédie

Nous avons visité le planning d'orthopédie ainsi que le planning général. Chaque planning a une méthode de fonctionnement légèrement différente, ce qui rend le remplacement en cas d'absence plus difficile.

Le système de planification reste similaire à celui de la chirurgie générale, mais il est globalement plus organisé. En effet, il s'agit de chirurgies plus « prévisibles », avec moins d'imprévus que dans d'autres disciplines, ce qui permet une meilleure anticipation du flux de lits. L'organisation y est perçue comme plus efficace, ce qui se traduit par une planification de meilleure qualité.

2.3 Interview – cheffe infirmière, service d'orthopédie

La journée type consiste à faire le tour des patients, réaliser les soins et gérer les entrées. L'après-midi est davantage consacré aux tâches administratives (planification des horaires, gestion des flux, etc.).

Un point fort du service d'orthopédie est la confiance entre tous les maillons de la chaîne (infirmier·ère-s, kinésithérapeutes et médecins). Par exemple, si l'équipe infirmière indique au kiné qu'un patient peut sortir, celui-ci prend cet avis en compte, vérifie la situation et, si cela se confirme, émet un avis favorable au médecin, qui intègre lui aussi ces retours avant de prendre sa décision.

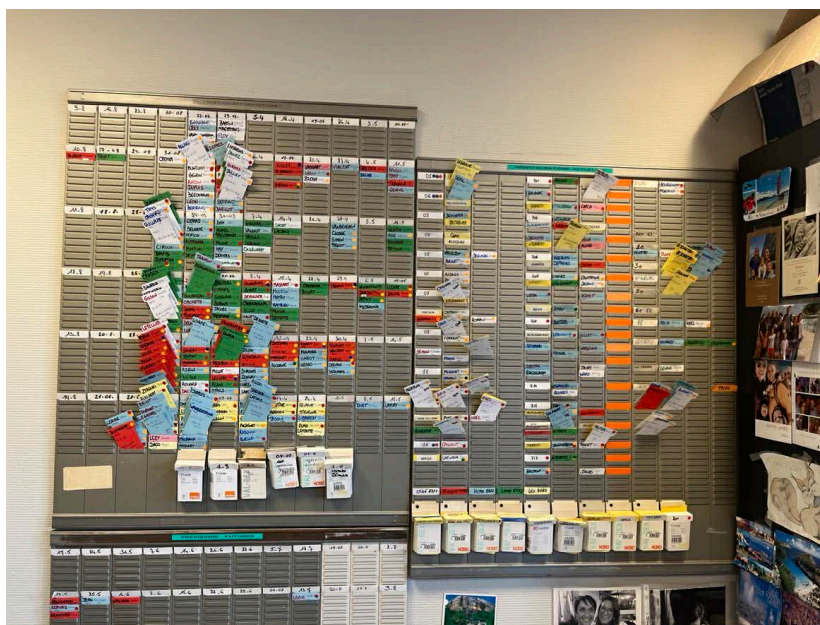


Figure 2: Exemple de tableau des hospitalisations actuelles

2.4 Interview patient

Nous avons interviewé un patient ayant bénéficié de la pose d'une prothèse de genou, qui a pu sortir à J+2 après l'opération.

Il rapporte avoir eu une excellente prise en charge : il a été très bien informé sur son opération, a rencontré un personnel soignant compétent et à l'écoute. Il connaissait ses dates potentielles de sortie et s'est organisé pour être récupéré en temps et en heure. Quelques jours après avoir pris rendez-vous pour son intervention, il a reçu différentes brochures expliquant le déroulement de son hospitalisation. Un mois avant l'opération, il a été invité par l'hôpital à assister à une présentation organisée par le service d'orthopédie. Lors de cette séance, il a pu poser toutes ses questions et manipuler une prothèse de genou, ce qui a renforcé sa compréhension et sa préparation.

2.5 Visite – planning médecine

Le planning de médecine fonctionne sur un principe similaire aux autres plannings. Le bureau de travail est cependant très exigu, ce qui reflète un manque de place plus général dans l'hôpital.

Le principal problème identifié est que la majorité des entrées proviennent des urgences, ce qui réduit fortement la possibilité de planifier à l'avance. Les équipes doivent constamment garder des lits libres pour les patients susceptibles d'arriver en urgence, ce qui n'est pas toujours évident à gérer au quotidien.

2.6 Problèmes identifiés

Lors de notre visite, nous avons pu identifier plusieurs problèmes, souvent imbriqués les uns dans les autres, ce qui rend la situation très complexe à appréhender avant même d'envisager des solutions. Parmi ceux-ci :

- Une des principales causes provient des sorties tardives. Une sortie réalisée en fin d'après-midi libère un lit qui ne sera réutilisé que le lendemain, alors qu'une sortie plus matinale permettrait de réutiliser le lit dans la journée.
- Certains chirurgiens se montrent relativement laxistes concernant la durée de séjour, ce qui conduit certains patients à rester plus longtemps que nécessaire et à occuper des lits inutilement.
- Certains patients ne souhaitent pas partir dans les délais prévus.

- D'autres s'organisent mal et n'ont personne pour venir les chercher, ou quittent l'hôpital en retard.
- La plupart des patients en orthopédie doivent voir le kinésithérapeute avant leur sortie, rendant impossible une sortie de tous les patients à, par exemple, 9h du matin.
- La planification des lits se fait actuellement à trois endroits différents, ce qui oblige les différents chefs de service à se déplacer aux quatre coins de l'hôpital.
- Il existe parfois des divergences de vision entre certains services (par exemple, des notes imprimées indiquant une heure maximale de libération des chambres à 11h, au lieu de 9h).
- L'imprévisibilité du service de chirurgie, liée aux urgences, complique l'anticipation des besoins en lits.
- On observe une disproportion dans le nombre d'interventions entre certains médecins : certains ont un volume d'interventions largement supérieur à la normale et occupent donc potentiellement davantage de lits.
- Des divergences existent dans la communication au patient : le chirurgien peut annoncer une durée de séjour qui ne correspond pas à l'idéal de planification des chefs de service.
- Enfin, certaines causes sont liées à l'empathie naturelle pour des cas spécifiques (grand âge, guérison plus lente, besoin d'accompagnement émotionnel, etc.), ce qui conduit à des durées de séjour plus longues, et par conséquent à une indisponibilité prolongée des lits.

Planning général

☐ Transfert ou réanimation
☒ Arrivé
☐ Quand là
● Privée
● Raison médicale
● Privée esthétique

Abdo-esthé	Cardio vascu	Dig et sein	Maxillo	ORL	Psg	URO
Blairvacq	Van Bell	Pierard	Dammous		Matet	Lefebvre
Schetini	Poncellet	Terwagne	Mathy			Delrée
Leblond	Buche F	Rubay				de Visscher
	Buche M	Ramboux				
	Etienne	Tamigneaux				
	Papadatos					

Planning ortho

☐ Entrée du dimanche
☒ Pas de rendez vous
● Privée
● Raison médicale
● Privée Goffin

Colonne	Goffin	Bras, avt bras, épaule, main	Hanche, bassin, fémur	Genou, MI	Pied
Devyver		Coquay	Himmer	Himmer	Devyver
Lambert		Opsomer	Mercier	Mercier	Theunissen
Daelemans		Stulko	Bingen	Bingen	
		Remy	Delpire	Daxhelat	
				Dalkosse	

Figure 3: Exemple de tableau des hospitalisations actuelles

1 WHO are we empathizing with?

Bed planing department
They assign a bed to each hospitalized patient
(current and future hospitalizations)

GOAL

2 What do they need to DO?

They need to make doctors understand that the lack of
beds is a problem that must be taken seriously.
Their job is to assign a bed for each patient, and find a
solution when there is not enough beds.
They are successful when each patient
has a bed on time.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

Their work is not given the
recognition it deserves.
Management does not listen to
them enough. They are worried
there won't be enough beds for
the patients. They are constantly
under pressure.

GAINS

They want more
comprehension from doctors.
They dream to have
enough beds for
every patient at any time.
They dream of having no
unexpected events so they
can plan everything in advance.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

They see their bed and patient charting system.
They see others saying that finding a solution is their job.
They see doctors doing what they want,
and everyone else has to fend for themselves

4 What do they SAY?

They're the only ones who can do their jobs,
so when some of them are absent, it's a disaster.
They are underconsidered compared to
the job they are doing.
That it's a tough and exhausting job.
That the most important thing is the
patient's well-being, while also taking
into account the financial
aspects of a hospital

5 What do they DO?

They do their job, assigning patients to beds.
Their behavior seems stressed and overwhelmed.

6 What do they HEAR?

Some colleagues sympathise with
them because of their work.
They are hearing that work takes lots of place
and they seem overwhelmed.
That they did a great job because because it is
extremely rare for an operation to be
cancelled due to a lack of beds

1 WHO are we empathizing with?

Patients

GOAL

2 What do they need to DO?

They need to organize themselves so be ready to leave the hospital on time.
They need to listen to medical staff when they say they are ready to leave.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

The operation going wrong,
complications, their return home,
delays in receiving care.

GAINS

That the operation goes
smoothly,
that they receive good care
that their needs are met,
and that their return
goes smoothly.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

They see the doctors and nurses looking after them.
They see high-quality care.

4 What do they SAY?

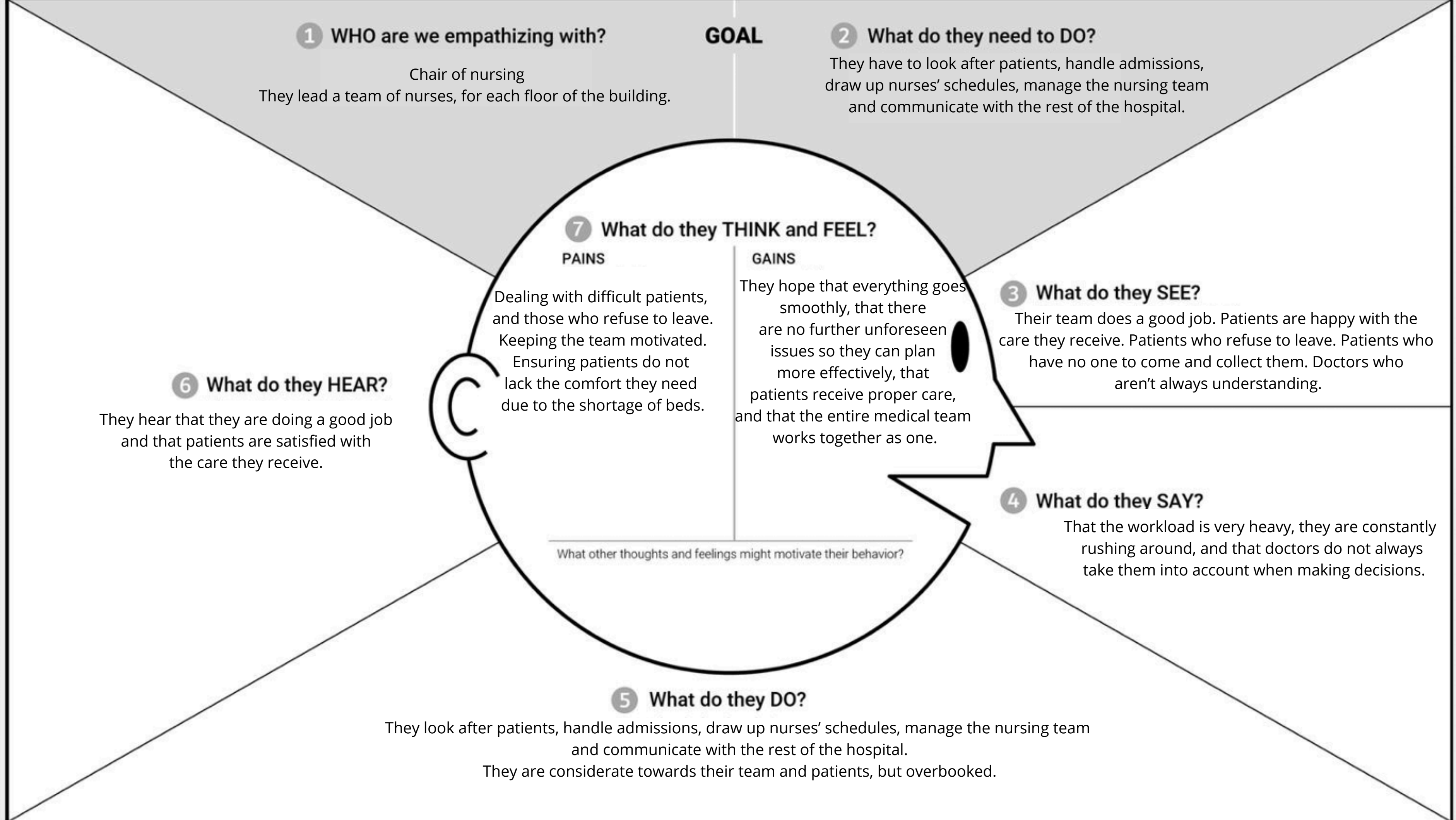
They say the care is excellent, that they were looked
after really well and were kept fully informed about
how the operation would go
and the likely date of their return.

5 What do they DO?

They undergo treatment and make arrangements to leave the hospital.

6 What do they HEAR?

As patients, they don't hear much apart
from what the nurses tell them.



1 WHO are we empathizing with?

Chair of nursing
They lead a team of nurses, for each floor of the building.

GOAL

2 What do they need to DO?

They have to look after patients, handle admissions, draw up nurses' schedules, manage the nursing team and communicate with the rest of the hospital.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

Dealing with difficult patients, and those who refuse to leave.
Keeping the team motivated.
Ensuring patients do not lack the comfort they need due to the shortage of beds.

GAINS

They hope that everything goes smoothly, that there are no further unforeseen issues so they can plan more effectively, that patients receive proper care, and that the entire medical team works together as one.

3 What do they SEE?

Their team does a good job. Patients are happy with the care they receive. Patients who refuse to leave. Patients who have no one to come and collect them. Doctors who aren't always understanding.

4 What do they SAY?

That the workload is very heavy, they are constantly rushing around, and that doctors do not always take them into account when making decisions.

5 What do they DO?

They look after patients, handle admissions, draw up nurses' schedules, manage the nursing team and communicate with the rest of the hospital.
They are considerate towards their team and patients, but overbooked.

6 What do they HEAR?

They hear that they are doing a good job and that patients are satisfied with the care they receive.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?